



EVALUACIÓN PREANESTÉSICA

Plantilla EVAPRE · Historia clínica de Hospitalización

N° 0201295631

30.SEP.2026 · 04:15 PM

Ámbito: QX

PACIENTE	DOCUMENTO	SEXO / EDAD
GONZALEZ RESTREPO MARIA FERNANDA	CC 1048291	Femenino · 67 años
DIAGNÓSTICO	CAMA	MÉDICO TRATANTE
J189 - NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	101-A	Dr. Camilo Grondona

INFORMACIÓN GENERAL

Procedimiento

FIBROBRONCOSCOPIA DIAGNOSTICA CON LAVADO BRONCOALVEOLAR Y CEPILLADO PROTEGIDO EN LOBULO INFERIOR DERECHO, BAJO SEDACION.

INDICACION: NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD SIN RESOLUCION RADIOLOGICA, CON FIEBRE INTERMITENTE E HIPOXEMIA LEVE PERSISTENTE A LOS 4 DIAS DE CEFTRIAXONA + CLARITROMICINA.

PROGRAMADA: 01.OCT.2026, SALA DE ENDOSCOPIA. SOLICITA: NEUMOLOGIA.

ANTECEDENTES

Patológicos	HIPERTENSION ARTERIAL DESDE 2014. DIABETES MELLITUS TIPO 2 NO INSULINORREQUIRIENTE DESDE 2017, HBA1C 7,4 % (JUN 2026). SIN EPOC, ASMA NI APNEA DEL SUEÑO CONOCIDA. SIN CARDIOPATIA, ARRITMIAS, ACV NI ENFERMEDAD RENAL. NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN MANEJO, HOSPITALIZADA DESDE 26.SEP.2026.
Quirúrgicos	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA (2015).
Obstetricos	F.U.M.: MENOPAUSIA A LOS 51 AÑOS GESTACION: 3 PARTO: 3 ABORTO: 0 CESAREA: 0 ECTOPICO: 0
Anestésicos	ANESTESIA GENERAL PARA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA (2015), SIN COMPLICACIONES NI VIA AEREA DIFICIL DOCUMENTADA. REFIERE NAUSEAS POSTOPERATORIAS LEVES (RIESGO DE NVPO). SIN ANTECEDENTE PERSONAL NI FAMILIAR DE HIPERTERMIA MALIGNA.
Tóxicos	EXFUMADORA, 15 PAQUETES/AÑO, SUSPENDIO HACE 12 AÑOS. NIEGA ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
Alergicos	PENICILINA: EXANTEMA MACULOPAPULAR MODERADO, SIN ANGIOEDEMA NI ANAFILAXIA. IBUPROFENO: BRONCOESPASMO LEVE. EVITAR AINES. LATEX, HUEVO Y SOYA: NIEGA.
Farmacologicos	HABITUALES: LOSARTAN 50 MG C/24 H (SUSPENDIDO AL INGRESO), METFORMINA 850 MG C/12 H (SUSPENDIDA), ATORVASTATINA 20 MG EN LA NOCHE. INTRAHOSPITALARIOS: CEFTRIAXONA 2 G IV C/24 H, CLARITROMICINA 500 MG VO C/12 H, ENOXAPARINA 40 MG SC C/24 H (PROFILAXIS), INSULINA CRISTALINA CORRECTIVA, OXIGENO POR CANULA NASAL.
Transfusional	NIEGA TRANSFUSIONES PREVIAS.

LABORATORIOS

HB	HCTO	Plaquetas
12,6 g/dL	38 %	312.000 /mm³
Leucocitos	TP	PTT
12.400 /mm³ (NEUTROFILOS 74 %)	12,8 s (CONTROL 12,0)	31 s (CONTROL 30)
INR	Glicemia	HbA1c
1,05	142 mg/dL	7,4 % (JUN 2026)
BUN	Creatinina	Ionograma
16 mg/dL	0,9 mg/dL (TFG 68 mL/min)	Na 138, K 4,0, Cl 102, Ca 9,0, Mg 1,9
Albúmina		

3,4 g/dL

Parcial de orina

DENSIDAD 1.015, PH 6, SIN PROTEINAS, GLUCOSA NI CETONAS. LEUCOCITOS 2-3 X CAMPO, NITRITOS NEGATIVOS.

Gases arteriales

PH: 7,43
PO2: 72 mmHg (CANULA NASAL 3 L/MIN, FIO2 ~0,32)
PCO2: 35 mmHg
BE: -1,2
LACTATO: 1,1 mmol/L
HCO3: 23 mEq/L

Otros (química sanguínea)

PCR 11,8 mg/dL (18,4 AL INGRESO). PROCALCITONINA 0,3 ng/mL. TGO 28 U/L, TGP 24 U/L.

EKG

RITMO SINUSAL A 84 LPM, EJE NORMAL, SIN ISQUEMIA, NI BLOQUEO DE RAMA. QTc 428 ms (CLARITROMICINA EN CURSO, VIGILAR).

RX Torax

CONSOLIDACION CON BRONCOGRAMA AEREO EN LOBULO INFERIOR DERECHO, SIN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS RESPECTO AL INGRESO. SILUETA CARDIACA NORMAL.

Otros (imagenes dx)

TAC DE TORAX CON CONTRASTE (29.SEP.2026): CONSOLIDACION EN LID SIN CAVITACION NI MASA ENDOBRONQUIAL. DERRAME PLEURAL DERECHO LAMINAR. ADENOPATIAS MEDIASTINALES REACTIVAS < 12 MM. SIN DEFECTOS DE LLENADO VASCULAR.

EXAMEN FÍSICO

Sensorio ALERTA, ORIENTADA, GLASGOW 15/15	TA mmHg 128/74	FC 84	FR 20	T °C 37,2	Peso kg 64	Talla cm 158	IMC 25,6
Protesis dental	Sí						
Tipo protesis	Parcial						
Lentes	Gafas						
Apertura oral	≥ 3 cm						
DTM	> 6,5 cm						
Distancia externomentoniana	≥ 12 cm						
Circunferencia de cuello	< 40 cm						
Test de la mordida	Clase I						
Distancia interincisivos	> 4 cm						
Mallampaty	Clase II						
Cabeza y O. de S.	PUPILAS ISOCORICAS, NORMOREACTIVAS. MUCOSAS ROSADAS, HUMEDAS, ANICTERICAS. DENTADURA NATURAL EN MAL ESTADO EN LA ARCADA INFERIOR.						
Cuello y cabeza	CUELLO MOVIL, SIN LIMITACION A LA FLEXO-EXTENSION NI MASAS. TRAQUEA CENTRAL. SIN INGURGITACION YUGULAR. PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE SUPERIOR (SE RETIRA ANTES DEL PROCEDIMIENTO).						
Cardioracico	RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, SIN SOPLOS. MURMULLO VESICULAR DISMINUIDO EN BASE DERECHA CON CREPITOS LOCALIZADOS, SIN SIBILANCIAS. SIN USO DE MUSCULOS ACCESORIOS.						
Abdomen	BLANDO, NO DOLOROSO A LA PALPACION, SIN MASAS NI MEGALIAS. PERISTATISMO POSITIVO						
GU	SIN ALTERACIONES. PUÑO PERCUSION NEGATIVA BILATERAL.						
Extremidades	PULSOS DISTALES SIMETRICOS ++. LLENADO CAPILAR < 2 SEGUNDOS. SIN EDEMAS						
Neurologico	GLASGOW 15/15. SIN DEFICIT MOTOR NI SENSITIVO. PARES CRANEALES CONSERVADOS.						

VALORACIÓN DEL RIESGO

Indice de Karnofsky	80. Actividad normal con algún esfuerzo: algunos signos o síntomas de enfermedad.
Estado fisico ASA	ASA III - Enfermedad sistémica severa
NYHA	Clase I
LEE ThRCI (Factores de riesgo)	Ninguno
LEE ThRCI (Puntos)	0 puntos
LEE Revisado (Factores de riesgo)	Ninguno
LEE Revisado (Clase)	Clase I
Capacidad funcional	Moderada (4 - 10 METs)

PLAN ANESTÉSICO

Tipo de anestesia	Sedación
UCI postquirúrgica	No
Hemoderivados	NO REQUIERE RESERVA DE HEMODERIVADOS (PROCEDIMIENTO CON BAJO RIESGO DE SANGRADO). GRUPO Y RH EN HISTORIA: O POSITIVO.

Recomendaciones

1. AYUNO 8 HORAS SOLIDOS, 6 HORAS LIQUIDOS CLAROS
2. SE EXPLICAN RIESGOS Y BENEFICIOS DE LA SEDACION, SE RESUELVEN DUDAS Y SE FIRMA CONSENTIMIENTO INFORMADO
3. CONTINUAR OXIGENO SUPLEMENTARIO HASTA EL INGRESO A SALA. META SPO2 >= 92 %
4. MANTENER SUSPENDIDOS METFORMINA Y LOSARTAN. GLUCOMETRIA ANTES DEL PROCEDIMIENTO, META 100-180 MG/DL
5. ULTIMA DOSIS DE ENOXAPARINA 12 HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO
6. ALERGIA A PENICILINA E IBUPROFENO: EVITAR AINES (KETOROLACO, DICLOFENACO) Y PENICILINAS. ANALGESIA CON ACETAMINOFEN
7. SALBUTAMOL 4 PUFF INHALADO 30 MINUTOS ANTES DEL PROCEDIMIENTO. PROFILAXIS DE NVPO: ONDANSETRON 4 MG IV (VIGILAR QTc)
8. RETIRAR PROTESIS DENTAL Y GAFAS ANTES DE INGRESAR A SALA

Análisis

PACIENTE FEMENINA DE 67 AÑOS, ASA III (DM2, HTA, NEUMONIA ACTIVA CON HIPOXEMIA LEVE), PROGRAMADA PARA FIBROBRONCOSCOPIA CON LAVADO BRONCOALVEOLAR. RIESGO CARDIOVASCULAR BAJO (LEE REVISADO CLASE I, 0 PUNTOS; NYHA I; CAPACIDAD FUNCIONAL > 4 METS), SIN NECESIDAD DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS ADICIONALES. VIA AEREA SIN PREDICTORES DE DIFICULTAD (MALLAMPATI II, APERTURA ORAL > 3 CM, DTM > 6,5 CM). RIESGO RESPIRATORIO ELEVADO POR NEUMONIA ACTIVA Y ANTECEDENTE DE BRONCOESPASMO CON AINES: SE PLANEA SEDACION PROFUNDA CON PROPOFOL + REMIFENTANILO, VIA AEREA COMPARTIDA CON CANULA NASAL DE ALTO FLUJO Y MONITORIA ESTANDAR ASA CON CAPNOGRAFIA. MASCARILLA LARINGEA E INTUBACION OROTRAQUEAL DE RESCATE DISPONIBLES. APTA PARA EL PROCEDIMIENTO CON LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES; REEVALUAR EL DIA DEL PROCEDIMIENTO SI SPO2 < 90 % CON FIO2 > 40 %.

VARGAS LOZANO JUAN PABLO

ANESTESIOLOGÍA · Médico

Firmado electrónicamente

30.SEP.2026 · 04:15 PM
Registro N° 0201295631